

การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมียุทธศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสม

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน อายุ ๑๙-๕๙ ปีมี BMI เกินได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมี BMI ลดลง	NA	๒	๓	๔	๕	๑.ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวัยทำงาน ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุคุณภาพ	๑. พัฒนาบุคลากรและแกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒	อัตราความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	NA	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๑.พัฒนาศักยภาพองค์กร-ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ๒.สร้างเสริมความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ๓.เยี่ยมเสริมพลัง	๑. องค์กร- ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพประเมินตนเองผ่านระบบโปรแกรมสาสุข อุ่นใจ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กร-ชุมชน ๓. ขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนตามกระบวนการสาสุขอุ่นใจ ข้อ ๔-๑๐ ๔. เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ และติดตาม
เป้าประสงค์ที่ 2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน								
๓	จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	พัฒนากลไกการขับเคลื่อน พขอ. รูปแบบ One Project one plan	๑. กำหนดประเด็น พขอ. ที่เป็นปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ๒. ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ พขอ. และ อนุกรรมการ พขอ. รายประเด็นให้เป็นปัจจุบัน ๓. วางแผนขับเคลื่อน พขอ. รูปแบบ one project one plan ทุกประเด็น ๔. บริหารจัดการบูรณาการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน พขอ. ๕. ประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE ก่อนและหลังดำเนินการ ๖. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน พขอ.

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔	ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	๗๗.๖๑	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๑.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ๒. เสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	๑.ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ๒.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลทศวรรษ ๑,๐๐๐ วัน สู่ ๒,๕๐๐ วัน และ สพด ๔D ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. การพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาเด็ก โดยการสร้างวินัยเชิงบวก โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม Trip P ๔.การแก้ไขปัญหาเด็กพัฒนากล้าเข้าเป็นรายบุคคล
๕	ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	๖๗.๒๓	๗๖	๗๘	๘๐	๘๒	๑.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ๒.สร้างความร่วมมือการดำเนินงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	๑.ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพ ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ๒.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลทศวรรษ ๑,๐๐๐ วัน สู่ ๒,๕๐๐ วัน และ สพด ๔D ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. การติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กที่ภาวะการเจริญเติบโตไม่สมวัย
๖	ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	๖๓.๐๘	๖๔	๖๖	๖๘	๗๒	๑.ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา ศักยภาพเด็กวัยเรียนศตวรรษที่ ๒๑ ๒.ยกระดับคุณภาพงานอนามัยโรงเรียน ๓.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	๑.ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล(GSHPS) ๒.ประเมินรับรองตามมาตรฐานด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน HPS,GSHPS ๓.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ทักษะสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน ๔.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน
๗	ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์	๙๔.๖	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	ยกระดับระบบการดูแลผู้สูงอายุ	จัดบริการสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสภาพดี (Healthy Aging) ป้องกันภาวะถดถอยด้านสุขภาพ สมองเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด พัลตตกกลม และมีสุขภาพจิตที่ดี

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๘	อัตราการมารดา ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสน การเกิดมีชีพ	๑๐.๑๔	≤๑๕	≤๑๔	≤๑๓	≤๑๒	๑.พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับโรงพยาบาล/ห้องคลอดคุณภาพ ๒.พัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุการตายของมารดา แนวทาง/ข้อปฏิบัติ/ข้อสั่งการ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตาย ๒. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงแก่หญิง ตั้งครรภ์ โดยการสร้างความตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่และใช้สมุด บันทึกสุขภาพแม่และเด็กและ Line OA แม่และเด็กเขต สุขภาพที่ ๗ ๓.กำกับติดตามการใช้นโยบาย/มาตรการในพื้นที่ โดยคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด MCHB และ Service Plan ทุก ๓ เดือนโดยการฝึกปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทาง สูติกรรม(Obstetric Crisis) ๓.พัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ในการ คัดกรองภาวะเสี่ยง การติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ เสี่ยงและการส่งต่อ อย่างเป็นระบบ
๙	อัตราการของทารกแรกเกิดไม่เกิน ๓.๖ ต่อพันการเกิดมีชีพ	๒.๗	๒.๕	๒.๓	๒.๑	๒	๑.พัฒนากลไกการขับเคลื่อน MCHB จังหวัดและ SP-สูตินรีเวชกรรม	๑.ประชุม MCHB ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อทบทวน ระบบการดูแลมารดาและทารกกรณี Death case and near Missed case เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ๒.ออกประเมินเพื่อรับรองโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน การดำเนินงานแม่และเด็ก

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๐	ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะฟันผุ	๙๔.๖๐	๙๕	๙๕.๕	๙๖	๙๖.๕	๑.สนับสนุนการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ๓.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑.สนับสนุนการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ๓.อบรม Case Manager Care giver อาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นและสหวิชาชีพ
๑๑	ร้อยละสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA	๓๙.๕๓	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๑. พัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ๒. เสริมสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชน	๑.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ๒.เพิ่มการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Self Collection ครอบคลุมทั้งจังหวัดขอนแก่น ๓.เพิ่มหน่วยเครือข่ายบริการการกระจายชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Self Collection ไปยังร้านยา คลินิกพยาบาล ๔.สนับสนุนการฉีดวัคซีน HPV
๑๒	ประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปี (รายใหม่) กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test	NA	๕๕	๖๐	๗๐	๘๐	๑. พัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ๒. เสริมสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชน	๑.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เรื่อง การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
๑๓	กลุ่มเป้าหมาย FIT Test ที่มีผล Positive ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy	๕๗.๕๔	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐		

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๔	อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน	๗๕.๑๒	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑. เพิ่มศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๒. พัฒนาเครือข่ายการคัดกรองเชื่อมโยงกับระบบ ๓ หมอ	๑. คัดกรอง ๓ กลุ่มเสี่ยงที่พบวัณโรคสูง ให้คัดกรองแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านสัมผัสใกล้ชิด, กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ หรือมี DM หรือมี COPD และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง ๒. คัดกรอง ๗ กลุ่มเสี่ยง โดยบูรณาการเป็นงานประจำในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกยาเสพติด, คลินิกโรคเรื้อรัง, คลินิก ARV เป็นต้น และจัดบริการ Mobile X-Ray ๓. ขยายศักยภาพในการตรวจ TB Lamp ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่ม จำนวน ๗ รพ. ได้แก่ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น รพ.บ้านไผ่ รพ.สีชมพู รพ.พล รพ.น้ำพอง รพ.มัญจาคีรี รพ.พระยืน ๔. อสม. ออกคัดกรอง HT DM ในกลุ่มเสี่ยง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในชุมชน เชื่อมโยงระบบ ๓ หมอ

เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๕	๑๕.๑ อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ลดลง	-๕.๙๘	๕	๖	๗	๘	๑. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนสามารถลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๒. พัฒนาระบบคัดกรองเชิงรุก	๑. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนสามารถลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
	๑๕.๒ อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ลดลง	๐.๗๘	๑	๒	๓	๔		
๑๖	จำนวนโรงพยาบาลที่ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับมาตรฐาน (Standard)	๒๔	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๑. สนับสนุนให้เกิดบูรณาการการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน ๒. ผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital อย่างเป็นรูปธรรม ๓. เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายการดำเนินงานระดับจังหวัด อำเภอ ทุกแห่ง ๒. เยี่ยมเสริมพลัง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระดับ ๓. ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการนิเทศงาน ๔. สนับสนุน วัสดุสาธิต งบประมาณ พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความต่อเนื่อง ยั่งยืน
	ระดับดีเยี่ยม (Excellent)	๑๒	๑๔	๑๖	๑๘	๒๐		
	ระดับท้าทาย (Challenge)	๓	๕	๖	๗	๘		
๑๗.	ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพตามเกณฑ์	NA	>๘๕	>๙๐	>๙๕	>๙๘	สนับสนุนระบบเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ	สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตให้ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม								
เป้าประสงค์ที่ ๔ ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๘	อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่	๗๕.๒๖	๘๘	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑.พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคระดับอำเภอ และ Mr.TB อำเภอ ๒.พัฒนาระบบการรักษา ส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูล การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	๑.จัดประชุม Case Conference เพื่อหารือแนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต และผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อน ๒. ขึ้นทะเบียน TB Clinic ในโรงพยาบาลระดับ F๓ จำนวน ๔ แห่ง
๑๙	ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับลดลง	๓.๐๗	๒	๑	๑	๑	พัฒนาคุณภาพการคัดกรองวินิจฉัยการส่งต่อดูแลรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งระบบอย่างบูรณาการ	ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีตาม ๘ มาตรการ
๒๐	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน ๘ ต่อประชากรแสนคน	๗.๙๙	๗.๑๙	๖.๓๙	๕.๕๙	๔.๗๙	๑.พัฒนาระบบคัดกรองเชิงรุก โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยง ๒.พัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล	๑.จัดระบบบริการตามแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา กลุ่มเสี่ยง ให้บริการภาวะฉุกเฉินด้าน จิตเวช รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
๒๑	อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด (Community-Acquired) น้อยกว่าร้อยละ ๒๖	๒๔.๙๗	๒๔	๒๔	๒๒	๒๐	๑.พัฒนากลไกการขับเคลื่อน SP สาขาอายุรกรรม ๒.พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย Sepsis ให้ได้มาตรฐาน ๓. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ	๑.ประชุมคณะกรรมการ SP สาขาอายุรกรรม (Sepsis) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ๒. สร้างทีมงานประสานงานและติดตามตัวชี้วัดในโรงพยาบาลทุกแห่ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
								โดยในแต่ละโรงพยาบาลต้องมี ทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และมีผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis case manager) รวมถึงการสร้างทีมเครือข่ายชุมชนในการคัดกรองผู้ป่วย ๓. ค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว (early detection) โดยใช้เครื่องมือในการช่วยคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือด เพื่อช่วยค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วและวินิจฉัยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ลดปัญหา Delay Detected / Delay Diagnosis/ Delay refer และการเพิ่มศักยภาพแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์แต่ละระดับ สร้างความเข้าใจ Protocol เพื่อการนำใช้ที่ถูกต้อง ๔. จัดทำแนวทางระบบการส่งต่อที่ชัดเจนเพื่อทำให้เกิดการสื่อสารและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแพทย์ พยาบาล ในทุกโรงพยาบาล เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและ สร้างแนวทางการพัฒนางานต่อไปให้สำเร็จมากยิ่งขึ้น

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๒	อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ต่อประชากรแสนคน	๒๗๔	๒๓๗	๒๓๒	๒๒๗	๒๒๒	พัฒนาระบบบริการโรคหัวใจและหลอดเลือด STROKE & STEMI ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ	๑. เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ อาการ สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจและหลอดเลือด ๒. คัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มป่วยโดยใช้โปรแกรม Smart NCD
๒๓	ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับการปรับสภาพและติดตามจนครบ ๖ เดือน หรือจน Barthel index = ๒๐ ก่อนครบ ๖ เดือน (เป้าหมายร้อยละ ๙๘)	๘๐	๙๘	๙๙	๑๐๐	๑๐๐	๑. ขับเคลื่อนการนำส่งข้อมูล (Data flow) ผ่านระบบโปรแกรม nRefer ๒. สนับสนุน ส่งเสริม การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนพื้นที่สุขภาพระยะกลาง ๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจักระบบบริการปรับสภาพระยะกลาง เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกายภาพบำบัด	๑. ชี้แจงการขึ้นทะเบียนระบบโปรแกรม nRefer ให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิสาธารณสุข ๒. ค้นหา/ ประสานงาน แหล่งงบประมาณการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางอย่างไร ร้อยต่อโดยเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ๓. ช่วยเหลือ สนับสนุนและบูรณาการการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางของหน่วยงานภาครัฐ (สสจ. รพ. กปท. อบจ.และ พมจ.) และองค์กรเอกชน ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Hybridge Meeting ๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๖. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย Service plan สาขาการบริการปรับสภาพระยะกลาง ๗. เสริมสร้างสนับสนุนนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๔	อัตราการติดเชื้อมียาในกระแสเลือด ลดลง ≥ 50	NA	≥ 50	55	60	65	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหน่วย บริการสุขภาพในชุมชน ให้มีการใช้ยา อย่างสมเหตุผล	๑.โรงพยาบาลมีการจัดการการติดต่อด้านจุลชีพ อย่างบูรณาการ ประเมินตนเอง (self assessment) และรายงานผลการดำเนินงานของ ทั้ง ๕ กิจกรรมสำคัญ ๒.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการ สุขภาพในชุมชน ให้มีการใช้ยาอย่างสม เหตุผล -การกำหนดนโยบายและมาตรการ ในรูปแบบ คณะกรรมการ -การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ของการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ยาด้านจุลชีพ -การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลการวิเคราะห์/ -สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ
๒๕	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรค หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	๘	≥ 20	≥ 21	≥ 22	≥ 23	ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการวินิจฉัยโรค หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง(Intermediate Care) เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ	๑.โรงพยาบาลชุมชน มีการ ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยใช้แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ด้านการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
๒๖	ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วย ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	๒๑.๔๓	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	๑. บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคี เครือข่าย ได้แก่ พชอ. ๓ หมอ ในการ ให้บริการการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก เช่น ผู้ป่วย NCD IMC LTC PC ปวด นอนไม่หลับ หงุดหงิดตลอด ผู้สูงอายุ

เป้าประสงค์ที่ ๕ ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๗	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุม น้ำตาลได้	๒๖.๖๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๑. ขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบ บูรณาการร่วมกับงาน NCD ๒.พัฒนาคุณภาพบริการตาม กระบวนการประเมิน NCD Clinic Plus ๓. ชุมชนต้นแบบลดหวานมันเค็ม	๑. พัฒนาบุคลากรและแกนนำในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ๒.
๒๘	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้	๕๓.๒๒	๖๐	๖๐	๖๐	๖๐		
๒๙	ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐม ภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๓.๐๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕		พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานปฐมภูมิใน การให้บริการ
๓๐	อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย (๖๐ : ๔๐)	๑๒.๑๒	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนใน การดูแลและจัดการระบบสุขภาพ								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
เป้าประสงค์ที่ ๖ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ								
๓๑	ร้อยละบุคลากรใน สสอ.ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย ๒ เรื่อง (Regulator & กฎหมายและ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)	NA	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐	พัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑.อบรมพัฒนาสมรรถนะหลัก ๒ เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย ๒ เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ๒. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการเข้ารับการอบรม
๓๒	ร้อยละหน่วยบริการได้รับการพัฒนากำลังคนตามแผนยกระดับระดับบริการสาธารณสุข (SAP)	NA	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ยกระดับหน่วยบริการตามแผนการ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ	จัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรงบประมาณ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
เป้าประสงค์ที่ ๗ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ								
๓๓	จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ จังหวัดขอนแก่น	๒๘๓ (เรื่อง)	๓๐๐ (เรื่อง) เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐	๓๓๐ (เรื่อง) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	๓๖๓ (เรื่อง) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	๔๐๐ (เรื่อง) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	๑.กำหนดประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประชาชน ๒.สนับสนุนด้านวิชาการแก่นักวิจัย ๓.สร้างแรงจูงใจ
๓๔	จำนวนหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล						๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน	๑.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒.ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน ๓.จัดหาและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกโรงพยาบาล ๓.กำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับเครือข่ายภายในเขตสุขภาพ
	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAIT	NA	๓	๖	๑๒	๒๖	๒. พัฒนาระบบสู่องค์กรดิจิทัล	
	Tele medicine	๑๔	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๓.พัฒนาบุคลากรรองรับระบบการแพทย์ทางไกลระบบคิวออนไลน์	
	Tele pharmacy	NA	๖	๑๒	๒๐	๒๖		
	คิวออนไลน์	NA	๖	๑๒	๒๐	๒๖		
	Replication รพ.สต.>๕๕	๑๘๕ (๗๔.๖๐%)	๒๔๘	๒๔๘	๒๔๘	๒๔๘	๔.พัฒนา platform	
๓๕	หน่วยบริการที่มีการบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด	๑๒,๓๙๒ ครั้ง	มีจำนวน รพ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และมีจำนวนการให้บริการไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ครั้ง	มีจำนวน รพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และให้บริการทางไกลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนครั้ง ในการนัดหมายในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	รพ.ทุกแห่ง ให้บริการทางไกล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนครั้ง ในการนัดหมายในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	รพ.ทุกแห่งให้บริการทางไกลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนครั้งในการนัดหมายในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรคเรื้อรัง ๕.เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารดิจิทัลกับประชาชน	

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
เป้าประสงค์ที่ ๘ หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน								
๓๖	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน HA ผ่านการรับรอง HA ชั้น ๓						-สร้างทีมเครือข่ายพี่เลี้ยง คุณภาพ (QLN) จ.ขอนแก่น -เตรียมความพร้อม รพ. ที่รับการ Acc./ Re accreditation - สนับสนุน รพ.๕๓ สู่กระบวนการคุณภาพ	-อบรมความรู้ พัฒนาทักษะ เครือข่ายพี่เลี้ยงคุณภาพ (QLN) -ลงพื้นที่เยี่ยมเตรียม ความพร้อม (Pre Survey)
	- รพศ./ รพท.	๓	๓	๓	๓	๓		
	- รพช.	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๑๙		
	- รพ. ระดับ ๕๓ (ตามเกณฑ์ที่ กำหนด)	๔	๔	๔	๔	๔		
๓๗	จำนวนสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์ SMART สสอ.	NA	๕	๑๐	๑๕	๒๐	พัฒนาสาธารณสุขอำเภอ ตามเกณฑ์ SMART สสอ.	ติดตามประเมินผลการให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๓๘	ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกสังกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ	๙๙.๓๒ (ประเมิน ตนเอง)	มีพื้นที่นำ ร่อง	๓๐	๔๐	๕๐	๑. พัฒนาระบบบริการปฐม ภูมิที่มีคุณภาพ ๒. พัฒนาบุคลากรปฐมภูมิ	ติดตามประเมินผลการให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
เป้าประสงค์ที่ ๙ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ								
๓๙	จำนวนโรงพยาบาลมีการบริหาร การเงินการคลังอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๕๓.๘๔ (๑๔ แห่ง)	๑๖ แห่ง	๒๐ แห่ง	๒๔ แห่ง	๒๖ แห่ง	พัฒนาหน่วยบริการตาม แนวทาง ๗Plus Efficiency Score/๔S๔C/Bright Spot Hospital/TPS Scoreและ HA Back Office	๑.อบรมพัฒนาศูนย์จัดเก็บ รายได้ ๒ ครั้ง -ลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลัง รพ. ที่มี ปัญหาสถานการณ์ทาง การเงิน ๒. ติดตามกำกับ โดย นำเสนอสถานการณ์ ทางการเงินผ่าน คกก.กวป.และ Dashboard ทางการเงิน